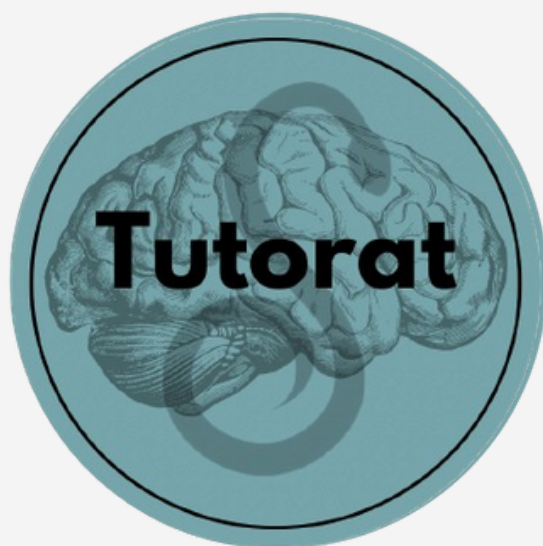


Normes **biologiques**

Les normes sanguines de base



NFS

La numération formule sanguine (NFS) joue un rôle essentiel dans le **diagnostic** et le **suivi** des patients. Elle permet de quantifier et d'étudier les différentes cellules du sang notamment les **globules rouges**, les **globules blancs** et les **plaquettes**.

- **Hématies : 4.2 - 5.7 millions/mm³ (H) | 4.0 - 5.3 millions/mm³ (F)**
- **Hémoglobine : 14 - 18 g/dl (H) | 12 - 15 g/dl (F)**
- **Hématocrite : 40 - 52 % (H) | 27 - 46 % (F)**
- **VGM : 80 - 100 fL**
- **Leucocytes: 4 000 - 10 000 /mm³**
- **PNN : 1 500 - 7 000 /mm³**
- **PNE : 50 - 500 /mm³**
- **PNB : 0 - 200 /mm³**
- **Lymphocytes : 1 500 - 4 000 /mm³**
- **Monocytes : 200 - 950 /mm³**
- **Plaquettes : 150 000 - 400 000 /mm³**

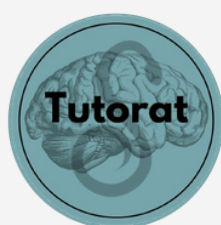


Ionogramme

L'ionogramme sanguin mesure les concentrations des électrolytes essentiels

Il est parfois associé à un ionogramme urinaire et la mesure de l'osmolarité pour fournir une évaluation plus complète, surtout dans les cas où l'organisme perd ou retient excessivement de l'eau, ce qui perturbe la balance hydroélectrolytique.

- Sodium : 133 - 143 mmol/L
- Potassium : 3.5 - 4.5 mmol/L
- Chlore : 95 - 105 mmol/L
- Bicarbonates : 22 - 29 mmol/L
- Phosphore : 0.8 - 1.35 mmol/L
- Magnésium : 0.75 - 1 mmol/L
- Calcium : 2.25 - 2.50 mmol/L



Bilan rénal

Ces tests reflètent la capacité des reins à **éliminer** les produits du catabolisme protéique et à **maintenir** l'équilibre hydrique et électrolytique

- **Urée : 2.5 - 7.5 mmol/L**
- **Créatinine : 50 - 115 μ mol/L**
- **Débit de filtration glomérulaire normal ou élevé :**

Stade 1 : DFG > 90 ml/min/1,73m² avec signes de dommages rénaux

- **Légère diminution du DFG :**

Stade 2 : DFG entre 60 - 89 ml/min/1,73m²

- **Diminution modérée du DFG :**

Stade 3a : DFG entre 45 - 59 ml/min/1,73m²

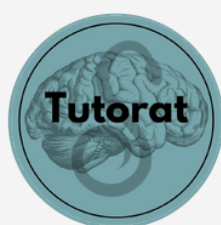
Stade 3b : DFG entre 30 - 44 ml/min/1,73m²

- **Diminution sévère du DFG :**

Stade 4 : DFG entre 15 - 29 ml/min/1,73m²

- **Insuffisance rénale terminale :**

Stade 5 : DFG < 15 ml/min/1,73m² ou dialyse

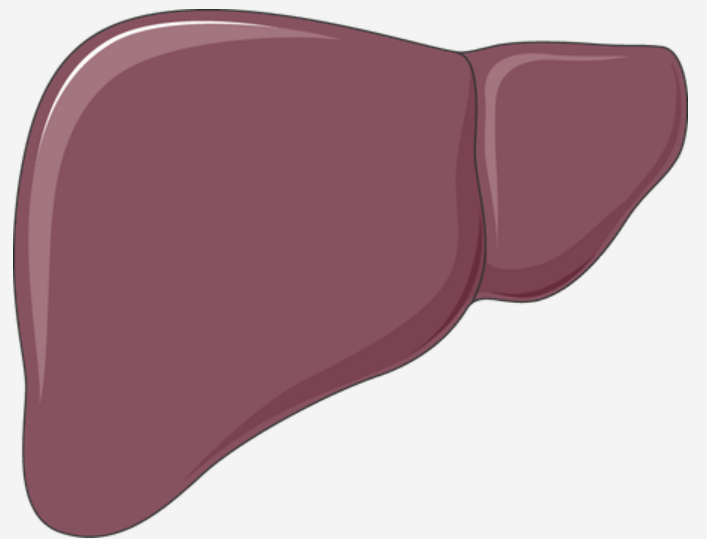


Bilan hépatique

Les enzymes hépatiques jouent des rôles variés dans l'organisme, de la digestion des aliments à la production et l'excrétion de substances chimiques essentielles

Les tests de la fonction hépatique permettent d'évaluer l'intégrité et l'efficacité du foie dans ces processus

- **ASAT : < 40 UI/L**
- **ALAT : < 30 UI/L**
- **LDH : 190 - 400 UI/L**
- **Gamma GT : < 58 UI/L**
- **PAL : < 34 U/100ml**
- **Bilirubine libre : 0.1 - 1.0 mg/dl**
- **Bilirubine conjuguée : 0.0 - 0.3 mg/dl**
- **Bilirubine totale : 0.3 - 1,2 mg/dl**

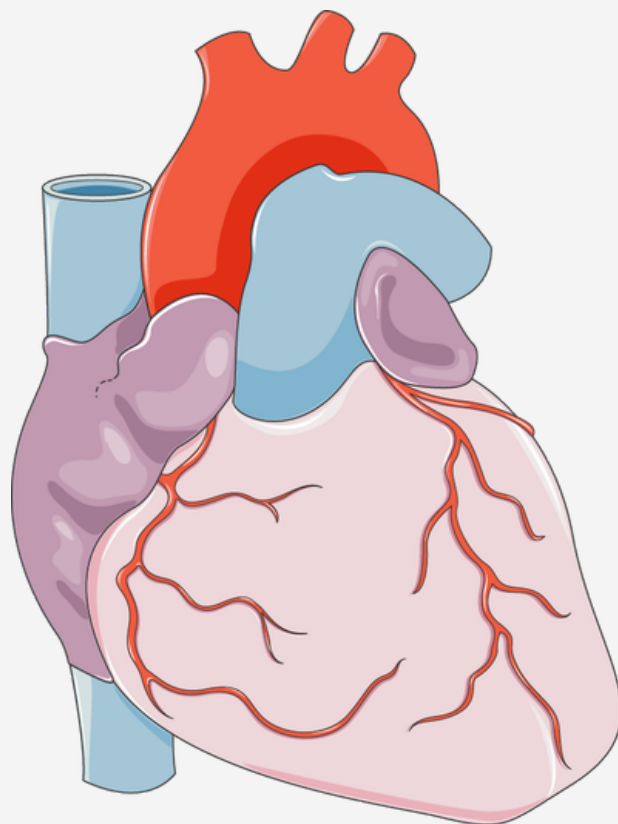


Bilan cardio

Les mesures des taux de troponine et des BNP (brain natriuretic peptide), sont essentielles pour évaluer les éventuelles lésions cardiaques.

La troponine indique des lésions myocardiques, tandis que les BNP correspondent à un biomarqueur utile pour le diagnostic et la gestion de l'insuffisance cardiaque.

- Troponine : Inférieure à 14pg/L, mais varie selon le laboratoire
- BNP : Moins de 100 pg/ml est généralement considéré comme normal

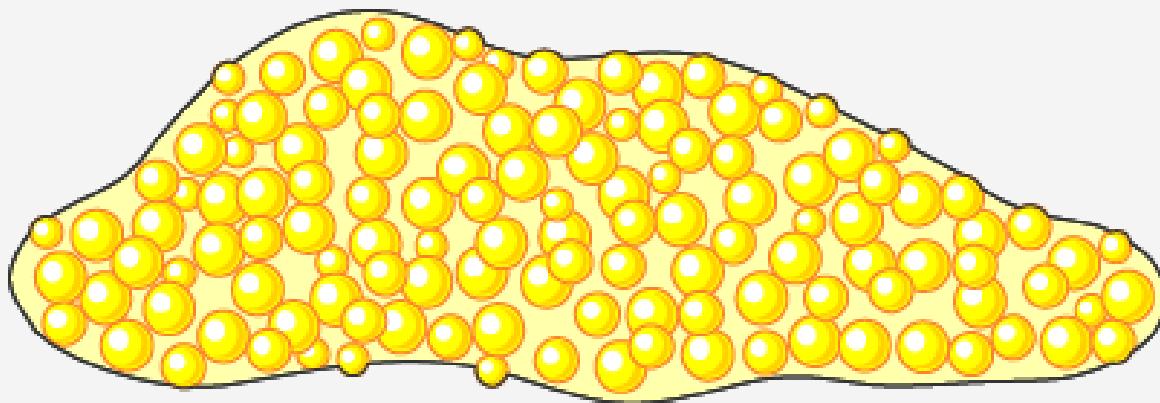


Bilan lipidiques

L'exploration d'une anomalie lipidique (EAL) évalue les **niveaux des lipides sanguins**, notamment le **cholestérol** et les **triglycérides**

Ces paramètres sont essentiels pour évaluer le **risque cardiovasculaire**, car ils influencent la formation de **plaques athéromateuses** dans les vaisseaux sanguins

- Cholestérol total : Moins de 2 g/l
- LDL - Cholestérol : Moins de 1,9 g/l
- HDL - Cholestérol : Supérieur à 0,4 g/l
- Triglycérides : Moins de 1,5 g/l

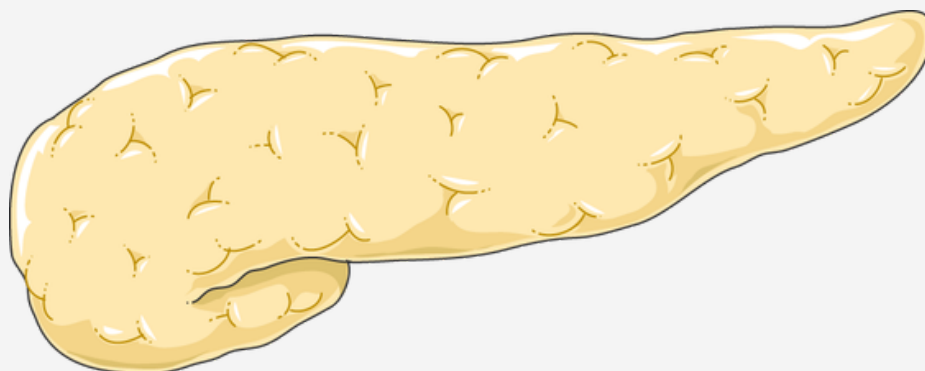


Bilan glycémique

La glycémie, qui est la mesure de la **concentration de glucose dans le sang**, joue un rôle important en tant qu'indicateur de l'état métabolique de l'organisme.

Le glucose est la principale source d'énergie des cellules et sa régulation est essentielle pour **maintenir les fonctions corporelles normales**.

- **Glycémie à jeun chez l'adulte :**
 - **0.70 - 1.10 g/L (3,89 mmol et 6,1 mmol/L)**
- **HbA1c :**
 - **Pour le diabète de type 2, généralement inférieure à 7%.**
 - **Pour le diabète de type 1, entre 7% et 7,5%.**



Bilan de coag

L'analyse de la coagulation sanguine permet d'évaluer les risques de saignements ou de thrombose, pour le suivi des traitements anticoagulant

Ainsi que de détecter les impacts de certaines pathologies comme les hépatopathies ou les maladies auto-immunes

- TP : > 70%

- INR :

1 pour les individus non traités

2 à 4 pour les patients sous AVK

- TCA : < 1,2 fois celui du témoin

- D-Dimères: < 500 $\mu\text{g/l}$ avant 50 ans, puis ajusté selon l'âge (< 10 x âge $\mu\text{g/l}$)

